בחינת שלב א'- התמחות על גריאטריה 21.12.21

1. מה התיאור הנכון לפתופיזיולוגיה של שבץ איסכמי?

א. שבץ משני ל-Patent Foramen Ovale הוא תמיד ממקור טרומבוזיס ורידי ו- paradoxical embolism

ב. שבץ של כלי דם גדולים נובע בשכיחות גבוהה מאמבוליה מ- common carotid artery

ג. אוטמים לקונרים נגרמים מאמבוליה ל- penetrating arteries מכלי דם ב- circle of Willis

ד. שבץ במנגנון artery to artery embolism יקרה בדרך כלל בכלי דם עם חסימה מוקדמת של >70%

2. מה מהווה שינוי נורמלי בהזדקנות על הלב?

א. הופעה של ציר ימני באק"ג

ב. ירידה ב- pulse pressure

ג. הופעה של mitral regurgitation

ד. ירידה ב- aortic impedance

3. מחלקה פנימית הזמינה ייעוץ בשאלה של מינוי אפוטרופוס. המטופלת בת 72 מאושפזת עקב אי ספיקת לב מתקדמת ואורמיה. לדברי הצוות החולה מבולבלת, אינה מתמצאת בסיטואציה. עקב אי ספיקה כלייתית זקוקה להכנסת צנתר לצורך התחלת דיאליזה. תואם תור להכנסת צנתר בעוד 3 ימים ומבקשים גריאטר למלא תעודת רופא.

מה הייעוץ המתאים במקרה זה?

א. מומחה ברפואה פנימית יכול למלא תעודת רופא ואין צורך בייעוץ גריאטרי

ב. כדאי לדחות את התור להכנסת הצנתר כי לא יהיה ניתן לסדר אפוטרופוס בפרק זמן זה

ג. מומלץ לבצע מבחן MMSE על מנת להעריך את יכולת השיפוט של החולה

ד. במקרה זה מספיקה הסכמה בעל פה של בן משפחה מדרגה ראשונה

4. מי מהחולים הבאים יופנה להתייעצות בשאלה של טיפול ב Deep brain stimulation (DBS) כטיפול במחלת פרקינסון ?

א. בת 74, סובלת ממחלת פרקינסון מתקדמת , דמנציה והזיות

ב. בן 82 הסובל מפרקינסוניזם קשה על רקע טיפול נוירולפטי

ג. בן 77, סובל מפרקינסוניזם על רקע ווסקולארי

ד. בן 83 הסובל מדיסקינזיות, מצבי On-off ותפקוד קוגניטיבי שמור

בחינת שלב א'- התמחות על גריאטריה 21.12.21

5. בת 74, חמישה ימים לאחר שחרורה מבית חולים על רקע החמרה באי ספיקת לב, הגיעה למעקב במרפאה. מתלוננת על קוצר בנשימה במאמץ.

ברקע ידוע על מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם, אי ספיקת לב, פרפור פרוזדורים, יתר שומנים בדם, אי ספיקה כלייתית כרונית.

תרופות:

VALSARTAN 160 mg X1

METOPROLOL 25 mg X1

FUROSEMIDE 40 mg X1

DIGOXIN 0.125 mg X1

APIXABAN 5 mg X2

SPIRONOLACTONE 12.5 mg X1

POTASSIUM CHLORIDE 20 mEq X1

בבדיקתה – ל"ד 126/76 בשכיבה, 128/78 בעמידה, דופק 77 לדקה, מספר נשימות 16 לדקה.

אין ממצאים בהאזנה לריאות, אין סימנים של עודף נוזלים, משקל יציב.

במעבדה :

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	136	135-146
K mmol/L	4.4	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.6	0.7-1.3
BUN mg/dL	30	5-25
Digoxin ng/mL	1.4	0.8-2.0

מה היא הפעולה הטובה ביותר לביצוע בשלב זה ?

א. להפסיק טיפול ב- SPIRONOLACTONE

ב. להעלות מינון FUSID לפעמיים ביום

ג. להקטין מינון של VALSARTAN

ד. להפסיק זמנית DIGOXIN ולחדש במינון מופחת

6. בן 78, מעשן כבד מתלונן על כאבים קשים ברגליים בזמן הליכה ואובחן כסובל מ- PERIFERAL VASCULAR DISEASE.

מה הגישה הטיפולית המתאימה ?

א. המלצה על הפסקת עישון היא מאוחרת מידי וכבר לא יכולה לשפר את המצב

ב. הדרכת המטופל ללכת מרחקים קצרים כדי לא להגיע למצב של כאב

ג. צנתור ואנגיופלסטיה של חסימה קצרה מתאים אם טיפול שמרני נכשל

ד. ניתוח רווסקולריזציה בהקדם האפשרי

7. מה יתרונות השירות האורתוגריאטרי ORTHOGERIATRIC COLLABORATION ?

א. השירות משפר הישרדות חולים באשפוז

ב. השירות מפחית הערבויות ניתוחיות

ג. השירות מאריך את משך האשפוז

ד. השירות לא משפיע על תמותה לטווח ארוך

8. מה המשפט המתאים לגבי מתן ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות?

א. נותן ההסבר לחולה שהוא נוטה למות יכול להיות רופא.ה או אח.ות

ב. אחד העדים יכול להיות מיופה הכוח עצמו

ג. נותן ההסבר לחולה שאינו נוטה למות הוא רק עורך דין

ד. אם מייפה הכוח הוא כבר חולה הנוטה למות, ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא/ה מומחה/ית

9. בת 80 סובלת מאוסטאופורוזיס, TIA בעבר ו- GERD. מטופלת ב- ASPIRIN, ESOMEPRAZOLE (NEXIUM) ו- ALENDRONATE (FOSALAN). התקבלה למחלקה פנימית עקב שלשול ואובחנה כסובלת מזיהום על ידי CLOSTRIDIUM DEFICILLE .

איזה מהבאים מגביר סיכון לחלות בזיהום ב- CLOSTRIDIUM DEFICILLE?

א. שימוש ממושך ב- ASPIRIN

ב. שימוש ממושך ב- ESOMEPRAZOLE (NEXIUM)

ג. שימוש ממושך ב- ALENDRONATE (FOSALAN)

ד. שימוש ממושך בפרוביוטיקה

10. התערבות מועילה למטופל שסובל מדליריום וכאב היא:

א. לתת טיפול תרופתי קבוע "סביב השעון" + טיפול לפי הצורך

ב. להימנע ממתן אופיואידים לכאב מתפרץ בעוצמה גבוהה

ג. מתן טיפול אנלגטי SOS לפי בקשת המטופל בכל פעם שהוא חש כאב

ד. תרופות נגד כאבים בשילוב עם תרופות אנטי פסיכוטיות

11. בת 80 הגיעה למרפאה למעקב של צפיפות העצם.

מטופלת ב- ALENDRONATE 70 מ"ג פעם בשבוע מזה 7 שנים בשל אוסטאופורוזיס.

בבדיקת צפיפות העצם T-SCORE -2.22 בצוואר ירך ימין.

ללא היסטוריה של שברים, ללא ירידה בגובה, ללא היסטוריה משפחתית של שברים בירך.

מה מהאפשרויות הבאות היא הניהול המתאים ביותר לבריאות העצם שלה ?

א. להמשך טיפול ב- ALENDRONATE

ב. להמשיך טיפול ב- ALENDRONATE ולהוסיף טיפול ב- TERIPARATIDE (FORTEO)

ג. להפסיק טיפול ב- ALENDRONATE

ד. להפסיק טיפול ב- ALENDRONATE ולתת טיפול ב- TERIPARATIDE (FORTEO)

12. מה מאפיין מבחני סקר לירידה קוגניטיבית?

א. רגישים באבחנה של ירידה קוגניטיבית בחולים עם תפקוד קוגניטיבי בסיסי גבוה

ב. לרוב יצביעו על ירידה קוגניטיבית אמתית גם בחולים עם רמת השכלה נמוכה

ג. דורשים השוואה לתפקוד קוגניטיבי קודם לצורך החלטה על המשמעות הקלינית שלהם

ד. מדויקים לצורך הערכת כשירות

13. מה הקשר בין מחלות הרקע לפתוגנים של דלקת ריאות?

א. COPD עם FEV1<35% מעלה סיכון לזיהום ב- Pseudomonas Aeruginosa

ב. סוכרת מעלה סיכון לזיהום ב- MRSA

ג. טיפול אנטיביוטי קודם מעלה סיכון לזיהום בחיידקים אנארובים

ד. נוכחות פצעי לחץ מעלה סיכון לזיהום ב- Enterbacteriaceae

14. מה היעילות של טיפול ב- MEMANTINE במחלת אלצהיימר?

א. יעיל לטיפול במחלת אלצהיימר קלה-בינונית

ב. הוכח כמשפר ADL

ג. משפר תפקודי למידה וזיכרון כאשר ניתן במינונים גבוהים

ד. יעילות הטיפול עולה במתן יחד עם מעכבי כולין אסטרז

15. מה מאפיין את אוכלוסיית הזקנים בארץ מבחינה כלכלית לפי לקט הנתונים האינפוגרפי של השנתון הסטטיסטי?

א. אחוז ההשתתפות של בני 65 פלוס בכוח העבודה הולך ופוחת עם השנים

ב. אחוז ההשתתפות של בני 65 פלוס בכוח העבודה בארץ הנמוך מבין מדינות ה- OECD

ג. אחוז הזקנים המקבלים השלמת הכנסה יורד עם השנים

ד. אחוז הזקנים שאינם עובדים ויש להם פנסיה יורד עם השנים

16. באיזה מהמטופלים הבאים <u>יש אינדיקציה</u> לביצוע תרבית שתן ?

א. בן 85 נשא נפרוסטום המתוכנן להחלפה אלקטיבית של הנפרוסטום, אסימפטומטי

ב. בן 78, נשא קתטר קבוע, מתוכנן להחלפה של הקתטר

ג. בת 73, דיירת מחלקה סיעודית, חום 38, בחילות והקאות, סטיק שתן תקין

ד. בת 78, חודש לאחר טיפול אנטיביוטי עקב צמיחת E. COLI בשתן

17. מה כוללות אמות המידה למתן טיפול שיקומי לקשיש?

א. הביטוח הלאומי מממן את האשפוז השיקומי כחלק מחוק סיעוד

ב. קיומן של מגבלות קודמות בתפקוד מהווה התוויית נגד לשיקום

ג. הנחיה לעיכוב דריכה מהווה סיבה לאי הפניה למסגרת שיקומית

ד. ההחלטה על מתן שיקום ויעדיו תקבע ע"י רופא מומחה בגריאטריה

18. מה הסיבה השכיחה ביותר לחום מסיבה שאינה ברורה (FUO) בגיל המבוגר ?

א. לימפומה

ב. דלקת עורקי הרקה (Temporal arteritis)/ Polymyalgia Rheumatica

ג. אנדוקרדיטיס זיהומית (infective endocarditis)

ד. תסחיף ריאתי (pulmonary embolism)

19. אשתו של בן 79, רופא גמלאי, מדווחת שבחודשים האחרונים חלה החמרה הדרגתית בזיכרון של בעלה. לדבריה הוא שוכח מה ביקשה ממנו לקנות בסופר ובאופן כללי פחות מרוכז ממה שהיה בעבר. היא מתלוננת שאומנם הוא ממשיך לבצע קניות בסופר, אבל לוקח לו הרבה יותר זמן מאשר בעבר. ממשיך לנהוג ללא תאונות או איבוד דרך.

באבחון MOCA השיג תוצאה של 25/30.

מה הטיפול המתאים במצב זה?

א. מעכבי אצטיל כולין אסטרז

ב. MEMANTINE

ג. נוגדי דיכאון

ד. פעילות גופנית ושינוי הרגלי חיים

20. מה מתאר את השינויים של מערכת החיסון בהזדקנות?

א. ייצור הציטוקינים הבזאלי יורד

ב. יכולת הפגוציטוזיס של הנויטרופילים עולה

ג. יכולת הכימוטקסיס של הנויטרופילים יורדת

ד. נצפית ירידה ב- Memory T cells

בחינת שלב א'- התמחות על גריאטריה 21.12.21

21. בן 72 , ברקע severe aortic stenosis פונה למיון עם שלשול ממושך מזה 5 ימים מלווה בחולשה קיצונית ומיעוט במתן שתן. סימנים חיוניים- סטורציה 97%, ל"ד 80/40, דופק 120. בבדיקות מעבדה (בטבלה בהמשך) נמצאה אי ספיקה כלייתית חדה. הוחל טיפול בעירוי נוזלים. ביום למחרת- עדיין ממעט במתן שתן. מתלונן על קוצר נשימה. סימנים חיוניים- סטורציה 88%, ל"ד 130/80 , דופק 98. בהאזנה לריאות ובצילום חזה- ממצאים מתאימים לגודש ריאתי.

בדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה		ערכים תקינים
	יום 1	יום 2	
Na mmol/L	142	130	135-146
K mmol/L	6.8	6.2	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	7.5	7.6	0.7-1.3
BUN mg/dL	77	58	5-25
Ph	7.21	7.28	7.34-7.45
PO2 mmHg	78	66	70-100
PCO2 mmHg	25	35	35-46
HCO3 mmol/L	15	18	21-26

אילו מבין הבאים הינו סיבה לדיאליזה דחופה בחולה זה?

א. עודף נוזלים

ב. היפרקלמיה

ג. קריאטנין מוגבר שלא יורד

ד. חמצת מטבולית

22. באילו מהמצבים הבאים יופעל מיופה כוח של אדם שחתם על ייפוי כוח מתמשך רפואי:

א. בת 76 שהוכרזה כחולה נוטה למות וזקוקה להקרנות כעת

ב. בן 94 המגיע לניתוח החלפת מפרק ירך אלקטיבי בליווי ביתו

ג. חולת דיאליזה בת 72 שנכנסה לדליריום וזקוקה להכנסת צנתר דיאליזה חדש

ד. בן 80 כבד שמיעה ששכח את מכשירי השמיעה בבית וכעת צריך להסכים לניתוח קיבוע שבר

23. בת 70 פנתה לברור עקב כאב גב. בהדמיה נמצא שבר בחוליה T8 ונגעים ליטיים מרובים.
במרפאה המטולוגית אובחנה כסובלת מ- IgG kappa MULTIPLE MYELOMA והוחל טיפול
ב- DEXAMETASONE ו- BROTEZOMIDE (VELCADE) .

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	138	135-146
K mmol/L	4.8	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	1.2	0.7-1.3
BUN mg/dL	42	5-25
Ca mg/dL	9.1	8.5-10.5
Albumin g/L	36	35-50
WBC 10e3/µL	5.8	4.0-11.0
HgB g/dL	11.2	אשה 11.7-15.5
Plt 10e3/µL	187	150-450

מה מבין התרופות הבאות היא המתאימה ביותר לחולה זו למניעת סיבוכים גרמיים?

א. denosumab (prolia)

ב. pamidronate (aredia)

ג. Calcium supplement with vitamin D

ד. Calcitonin

24. בן 60, רקע רפואי של יתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, ירידה בראיה (מרכיב משקפיים) וקושי בשמיעה.

תרופותיו כוללות:

RAMIPRIL (TRITACE) 5 mg X1

ASPIRIN 100 mg X1

SIMVASTATIN 20 mg X1

ATENOLOL (NORMITEN) 50 mg X1

אילו מבין ההתערבויות הבאות מוכחת כמוריד סיכון להופעת דמנציה בחולה זה?

א. שימוש במכשירי שמיעה

ב. הרכבת משקפיים ביפוקאליים

ג. העלאת מינון SIMVASTATIN ל-40 מ"ג

ד. הוספת SPIRINOLACTONE לטיפול התרופתי

25. למי מבין החולים הבאים יהיה PADUA SCORE הגבוה ביותר?

א. בן 89, סיעודי ומרותק למיטה מזה שנה

ב. בן 75, מטופל באשפוז יום עקב אי ספיקת לב

ג. בן 71, יממה לאחר ניתוח עקב CA OF COLON

ד. בת 68, סובלת מ- MORBID OBESITY, מטופלת ב- hormone replacement therapy, מתהלכת עם הליכון

26. בן 84, עצמאי ושמור קוגניטיבית, ברקע יתר לחץ דם מאוזן ומחלת קרוהן בהפוגה. אובחן כסובל מקרצינומה של הערמונית Gleason 5 ללא גרורות. הוא מתלבט בין טיפולים מקומיים שהוצעו לו.

איזה שיקול ינחה את תכנית הטיפול המקומי בקרצינומה של הערמונית?

א. radical prostatectomy בניתוח "פתוח" יעיל יותר מניתוח לפרוסקופי במקרה של ממאירות

ב. מחלת מעי דלקתית מהווה קונטראינדיקציה יחסית לטיפול קרינתי חיצוני external beam (radiation therapy)

ג. טיפול ב- brachytherapy כרוך בסיכון גבוה לאי שליטה על שתן לטווח ארוך

ד. טיפול הורמונלי נאו-אדג'ובנטי יכול להפחית סיבוכים גם של ניתוח וגם של קרינה

27. בן 82 ללא מחלות רקע ידועות וללא טיפול תרופתי קבוע . פיתח פרפור פרוזדורים לאחרונה. הותחל טיפול תרופתי בנוגדי קרישה ובהמשך ב- AMIDARONE (PROCOR).

בבדיקות מעבדה לאחר שבועיים:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
TSH mu/L	7.8	0.4-4.7
FT4 ng/dL	2.3	0.7-1.8
TT3 ng/dL	55	60-180

כיצד יש להתערב בעקבות הפתולוגיה בבדיקות המעבדה?

א. מדובר בתירוטוקסיקוזיס. יש להוסיף לטיפול תכשיר חוסם ביטא

ב. מדובר בתופעת לואי שכיחה. במצב המתואר מומלץ מעקב בלבד

ג. תמונה של תירואידיטיס. מומלץ לתת טיפול ב- Methimazole

ד. מדובר בתופעת לואי נדירה ומסכנת חיים, יש להפסיק טיפול בAmiodarone ולתת טיפול ב Elthroxin

28. מה הקשר בין ALZHEIMER DISEASE (AD) לדיכאון?

א. רוב חולי ה- AD סובלים גם מדיכאון

ב. דיכאון בחולי AD מתבטא פחות בהפרעות שינה ותיאבון

ג. סימן מוקדם לדיכאון בחולי AD יכול להיות עליה באיריטביליות

ד. סימן מוקדם לדיכאון בחולי AD הינו מחשבות אובדניות

29. בן 85 , גר לבדו, תשוש בתפקודו ומקבל עזרה ממטפלת 6 שעות לשבוע. בעל השכלה גבוהה. ללא ירידה קוגניטיבית ידועה. ברקע יתר לחץ דם, סכרת והיפרליפידמיה.

כעת מאושפז במחלקה פנימית לאחר שנפל בבית, ללא שבר. ביום השני של האשפוז מבולבל מאד לסירוגין.

בשיחה עם החולה- רגוע ומשתף פעולה, אך מוסח בקלות ועובר מנושא לנושא. בוצעו מבחנים קוגניטיביים .

מה מהמבחנים הקוגניטיביים מתאים למצבו ?

א. MMSE- התמצאות בזמן 3/5 , התמצאות במקום 3/5 ,זיכרון מידי 3/3, קשב וריכוז 2/5 , זיכרון קצר 0/3 , מבחן שעון 3/10

ב. MMSE - התמצאות בזמן 5/5 , התמצאות במקום 4/5 , זיכרון מידי 3/3 , קשב וריכוז 5/5, זיכרון קצר 2/3 , מבחן שעון 9/10

ג. MMSE - התמצאות בזמן 0/5 , התמצאות במקום 1/5 , זיכרון מידי 2/3 , זיכרון קצר 0/3 ,קשב וריכוז 4/5 , מבחן שעון 0/10

ד. על כל שאלה עונה "לא יודע " אך יודע להשתמש בסמארטפון אשר נמצא ברשותו

30. בן 80, סבל 5 פעמים במשך שלושת השנים האחרונות מדימום מוחי לובארי (Lobar hemorrhage)

מה סיבת הדימום השכיחה במצב זה?

א. דימום מגרורות

ב. vasculitis

ג. Cerebral amyloid angiopathy

ד. נפילות עם חבלות ראש חוזרות

31. חולה במחלת פרקינסון מתקדמת הסובל מהזיות ראיה מפחידות , מה הטיפול ?

א. עליה במינון ה- DOPICAR

ב. מתן QUETIAPINE (SEROQUEL)

ג. הוספת תרופה ממשפחת האנטיכולינרגים

ד. הוספת טיפול בתרופה ממשפחת הבנזודיאזפינים

32. בת 77, פנתה לבדיקה שגרתית. מדובר בפנייה ראשונה למרפאה מזה כ-10 שנים.
בבדיקות דם שביצעה לפני כשבוע, שלא בצום, סוכר 184 מ"ג/ד"ל, המוגלובין A1C- 6.2% . האם מדובר בסוכרת?

א. למטופלת אבחנה של טרום סוכרת

ב. למטופלת אבחנה של סוכרת

ג. לא ניתן לאבחן לפי בדיקה זו. יש צורך בבדיקות נוספות

ד. מדובר בשינוי פיזיולוגי. מומלצת בדיקה חוזרת בעוד שנה

33. בן 87 הוא חולה נוטה למות עקב אי ספיקת לב סופנית. בעבר חתם על מינוי ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות. כעת הוא נמצא באשפוז במחלקה קרדיולוגית בשל סינקופה המיוחס לחסם הולכתי וזקוק להכנסת קוצב.

מי קובע אם החולה כשיר לקבל החלטה או שיש להפעיל את מיופה הכוח?

א. רק גריאטר יכול להחליט על הוצאה מחזקת הכשרות על פי חוק החולה הנוטה למות

ב. רופא מומחה לפי בחירת החולה (בזמן שמילא את הטופס) יכול להחליט על הוצאה מחזקת הכשרות על פי חוק החולה הנוטה למות

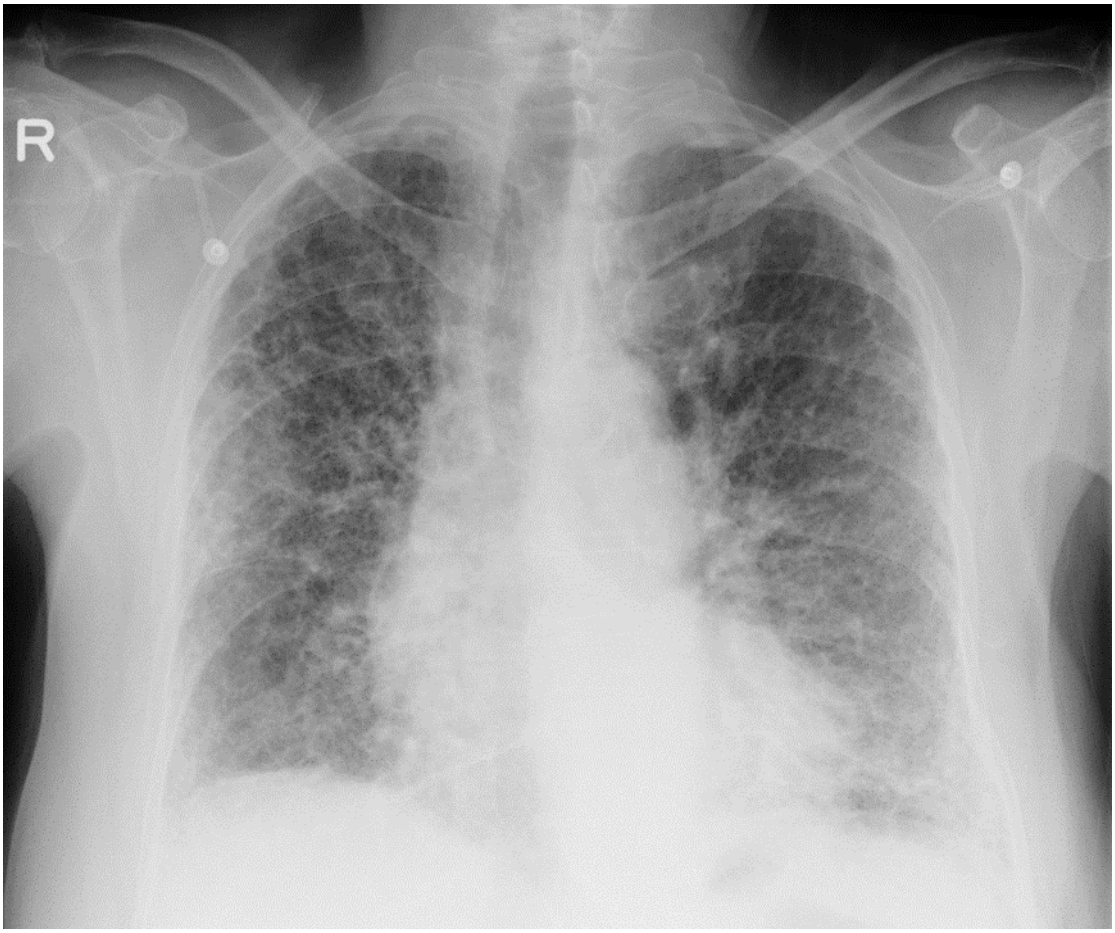
ג. רק אם הרופא האחראי הוא גריאטר או פסיכיאטר, הוא יכול להחליט על הוצאה מחזקת הכשרות

ד. כל רופא שהוגדר כרופא אחראי יכול להוציא מחזקת הכשרות על פי חוק זה

34. בן 70, ברקע בריא, ללא עישון בעבר, ללא טיפול תרופתי. פונה בשל קשיי נשימה שהתחילו בצורה הדרגתית. הוא שולל חשיפה לאסבסט, סיליקה, חציר או ציפורים.

בבדיקתו – סטורציה 90% באוויר חדר, בהאזנה לריאות – קרפיטציות עדינות דו צדדיות . אקו לב בגדר הנורמה.

צילום חזה – ראה תמונה 1



אילו מהטיפולים הבאים יכול להאט את הדרדרות מחלתו?

א. PREDNISONE

ב. RITUXIMAB (MABTHERA)

ג. METHOTREXATE

ד. NINTEDANIB (OFEV)

35. בן 84, עצמאי ושמור קוגניטיבית, ברקע סכרת, יתר לחץ דם. מתלונן על חולשה והרגשה כללית לא טובה מזה כחודשיים. מדווח על כאבים בכתפיים, יותר בשעות הבוקר. בבדיקות מעבדה - HB 10.1 עם MCV 65 , ללא לויקוציטוזיס, כימיה בגדר הנורמה, רמת CRP- 65. ראומטואיד פקטור חיובי, ANA שלילי . ב- EMG סימנים אופייניים של inflammatory myopathy.

הועלה חשד ל- לPolymyalgia Rheumatica (PMR).

איזה ממצא תורם לאבחון של PMR בחולה זה?

א. rheumatoid factor חיובי

ב. ANA שלילי

ג. ב- EMG סימנים אופייניים של inflammatory myopathy

ד. אנמיה מיקרוציטית

36. בן 83 אמור לעבור בעוד חודש ניתוח אלקטיבי של תיקון הרניה מפשעתית מימין.

ברקע: מחלת לב איסכמית, אי ספיקת כליות כרונית, יתר לחץ דם וטרום סוכרת.

באק"ג שגרתי נמצא RBBB.

בבדיקות המעבדה לפני הניתוח-

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	142	135-146
K mmol/L	5.1	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	2.2	0.7-1.3
BUN mg/dL	46	5-25
Glucose mg/dL	117	72-100

מה משפיע על הסיבוכים הקרדיאליים הצפויים לאחר הניתוח?

א. נוכחות טרום סוכרת

ב. Mild Mitral regurgitation

ג. קריאטינין >2

ד. פתולוגיה בבדיקת אק"ג

37. חולה בן 71 , דייר הוסטל, הופנה לחדר מיון עקב חולשה כללית , נפילות חוזרות , רעד בידיים ובלבול אשר החמירו במשך שבועיים . ברקע ידוע על מחלה דו קוטבית , צהבת מסוג C , יתר לחץ דם , ערמונית מוגדלת , עישון כבד .

לפי מכתב הפניה החולה מטופל ב:

FESOTERODINE (TOVIAZ) 8 mg

OLANZAPINE (ZYPREXA) 5 mg

RAMIPRIL (TRITACE) 5 mg

LITHIUM 600 mg

לפי מערכת "אופק " לפני חודש הוסף טיפול ב - DISOTHIAZIDE .

בבדיקה חולה ישנוני סטורציה 97% באוויר חדר , ל"ד 100/60 , דופק 54 סדיר , חום 36.7, מגיב לכאב עמוק בלבד .ללא סימני צד .רעד בידיים בזמן גירוי בצורת CLONUS.

מה הצעד הבא שיעזור באבחנה?

א. יעוץ נוירולוג , CT ראש ובמידה ותקין –בדיקת LP

ב. מעבדה כולל רמת LITIUM בדם

ג. בדיקה נוירולוגית ,CT ראש , EEG

ד. שתן לטוקסיקולוגיה , בדיקת גזים , אק"ג

38. מה אפייני לסימפטומים במחלת Gastroesophageal Reflux Disease -GERD בקשישים לעומת צעירים:

א. סימפטומים אופייניים (צרבת, כאב) נעשים שכיחים יותר עם העלייה בגיל

ב. סימפטומים אטיפיים (אסטמה, ברונכיטיס, צרידות) נעשים שכיחים יותר עם העלייה בגיל

ג. סימפטומים לא ספציפיים (דיספגיה, אנורקסיה, אנמיה) נעשים שכיחים יותר עם העלייה בגיל

ד. הסימפטומים בקשישים דומים לסימפטומים בצעירים

39. בת 92, סיעודית וסובלת מדמנציה מתקדמת אושפזה במחלקה כירורגית עקב חום , ירידה במצב ההכרה וכאבי בטן. בדיקת אולטרסאונד הדגימה דלקת בכיס מרה. הוחל טיפול באנטיביוטיקה ונוזלים. במקביל פיתחה פרפור עליות וגודש ריאתי.

מה הגישה הטיפולית המתאימה לחולה זו?

א. כריתת כיס מרה בגישה פתוחה

ב. טיפול שמרני בנוזלים ואנטיביוטיקה בלבד

ג. כריתת כיס מרה לפרוסקופית

ד. ביצוע gallbladder drainage

40. בן 88, סובל מפצע לחץ בטרוכנטר ימין.

ראה תמונה 2 .

הוא מטופל בביתו ע"י משפחתו המעוניינים בטיפול האופטימלי עבור ומוכנים לקנות כל תכשיר.

מה התכשיר המומלץ לניקוי הפצע לפני החלפת חבישה?

א. מי חמצן 3%

ב. תמיסת NaCl 0.9%

ג. מים מינרלים סטריליים

ד. Polydin 10%

41. מה המנגנון המתאים לתרופות לעצירות?

א. (LEVOLAC) LACTULOSE- דו סוכר שאינו נספג ומפורק על ידי חידקי המעיים

ב. (LAXADIN) BISACODYL - הפעלה של cholecystokinin

ג. SENNA – גירוי מקומי על פעילות הרקטום

ד. (NORMALAX) POLYETHILENE GLYCOL – סיבים הסופחים מים ומגדילים את נפח הצואה

42. מחלקה פנימית מבקשת יעוץ גריאטרי על מנת להגדיר מצבו של חולה כסיעודי, לצורך קביעת זכאות רפואית ל"קוד" של משרד הבריאות. מה תהיה המלצתך?

א. אם החולה עומד בהגדרות הקליניות, אגדיר אותו כסיעודי ואתן לו אישור לקוד

ב. רק גריאטר מחוזי יכול להגדיר את החולה כסיעודי

ג. אם החולה עומד בהגדרות הקליניות, אמליץ על הגדרתו כסיעודי. אישור לקוד ניתן רק על ידי גריאטרי מחוזי

ד. אין צורך בייעוץ. מומחה ברפואה פנימית יכול להגדיר חולה כסיעודי

43. בת 70 , ברקע אי ספיקת לב וסוכרת , התקבלה במרפאתך בגלל אירועים תכופים של בריחת שתן. לדבריה, אלה מתרחשים ללא אזהרה, בדרך כלל בהקשר של שיעול או עיטוש.

איזו מההתערבויות הללו היא בעלת הסבירות הגבוהה ביותר לסייע בבריחת שתן?

א. טיפול תרופתי ב- (VESICARE) TOLTERODINR

ב. טיפול במשחת אסטרוגן מקומית

ג. תרגילי שרירי האגן (קיגל)

ד. ציסטופלסטיקה (הרחבת השלפוחית)

44. בת 89, מאושפזת לשיקום לאחר שבר ב RAMUS PUBIS. ברקע מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם והיפרליפידמיה. באשפוז הופעת גרד עורי והוחל טיפול באנטיהיסטמין.

כעת מטופלת בתרופות הבאות:

TARGIN (OXYCODONE/NALOXONE) 10 mgX2

LERCANDIPINE (VASODIP) 10 mgX2

MIRTAZAPINE (MIRO) 15 mgX2

OMEPRADEX 20 mgX2

BISOPROLOL (CARDILOC) 1.25 mgX1

LORATADINE (LORASTINE) 10 mgX1

OXAZEPAM (VABEN) 10 mgX1

CALCIUM 600 mgX1

VITAMIN D 2000 unitsX1

המטופלת מתקדמת בתהליך השיקומי ומתהלכת בהשגחה עם הליכון. מתלוננת על בריחת שתן ללא קשר לשיעול או צחוק. בנוסף, זרם השתן חלש מהרגיל, ובלילה מתעוררת כל שעתיים לשירותים. שוללת עצירות.

בדיקת שארית על ידי BLADDER SCAN מדגימה שארית של 300 סמ"ק.

מהו הצעד הראשון שיש לנקוט בו, כדי לשפר בצורה הטובה ביותר את ההפרעה בנקיטת שתן שמתוארת?

א. הפסקת הטיפול ב- TARGIN וב- LORATADINE

ב. התרוקנויות יזומות לצורך אימון שלפוחית השתן

ג. הוספת טיפול בחוסם אלפא כגון ALFUZOCIN

ד. המשך טיפול שיקומי. כאשר תגיע לניידות עצמאית, ההפרעה תסתדר

45. בת 71 ללא מחלות רקע ,לא נוטלת תרופות קבועות, אינה מעשנת ולא שותה אלכוהול. שמורה קוגניטיבית ועצמאית בתפקוד. מתלוננת מזה מספר חודש על הפרעה במתן השתן המתבטאת במתן שתן לעתים קרובות גם ביום וגם בלילה ודחף פתאומי שקשה לשלול עליו לתת שתן, ללא תלונות נוספות. בדיקת שתן לכללית תקינה, ספירת דם וכימיה ללא ממצא חריג.

איזה טיפול מומלץ ?

א. טיפול תרופתי באלפא אנטגוניסטים ארוכי טווח כגון ALFUZOCIN (XATRAL)

ב. שינויים בדיור כדי לאפשר גישה נוחה לשירותים

ג. טיפול תרופתי בבטא-3 אגוניסט כגון MIRABEGRON (BETMIGA)

ד. שימוש במשחה סטרואידלית וגינלית מקומית

46. בת 87 אושפזה עקב אי ספיקת לב מתקדמת עם אנסרקה ותסמונת קרדיו-רנלית. סירבה דיאליזה ומבקשת לקבל טיפול פליאטיבי בלבד.

מה העקרונות במתן טיפול הפליאטיבי בחולה זו?

א. טיפול תוך ורידי ב- FUSID IV אינו מוגדר כטיפול פליאטיבי

ב. יש צורך בתישאול יומי לגבי קיום של עצירות

ג. טיפול ב- MORPHINE כטיפול הבחירה לכאבים

ד. מעקב יומי של תפקודי כליה ואלקטרוליטים יעזור בבניית תכנית הטיפול

47. בן 74 , הסובל מ- COPD על רקע עישון כבד אובחן כסובל מ- NON SMALL CELL CARCINOMA של הריאה עם גרורות מרובות. הוא מאושפז במחלקה פנימית ומתלונן על קוצר נשימה. סטורציה 92%.

מה עקרונות הטיפול הפליאטיבי בו?

א. מתן חמצן רק אם הסטורציה פחות מ- 90%

ב. OXYCODONE היא תרופת הבחירה לקוצר נשימה

ג. טכניקת הרפיה מועילה רק במידה וטיפול תרופתי נכשל

ד. הנשמה לא פולשנית יכולה לעזור בהקלת הסימפטומים

48. בן 74 סובל מעודף משקל עם BMI- 30 .

מה הסיכון הנגרם לו כתוצאה מעודף משקל?

א. סיכון מוגבר לאי שליטה על שתן

ב. הסיכון לתמותה שלו גבוה משמעותית מאדם בגילו עם BMI-22

ג. סיכון מוגבר לאוסטאופורוזיס

ד. סיכון מוגבר לסרקופניה

49. בן 81 סובל מדמנציה ודייר מחלקה סיעודית התקבל לבית חולים עקב אי שקט פסיכומוטורי. CAM חיובי. טיפול סביבתי לא שיפר את מצבו ועלה צורך במתן טיפול תרופתי.

מה הסיבוכים של טיפול תרופתי אנטי פסיכוטי בחולה זה?

א. QUETIAPINE (SEROQUEL) מגביר רעד ונוקשות ברוב החולים

ב. HALOPERIDOL מעלה סיכון לפקקת ורידים עמוקה

ג. טיפול אנטי פסיכוטי מעלה תמותה מסיבות קרדיווסקולרית

ד. הסיכון של טיפול אנטי פסיכוטי הוא אידיוסינקרטי ואינו תלוי במינון

50. בת 77 פונה להערכה גריאטרית כוללנית. באנמנזה תרופתית מדווח על שימוש ממושך ב- CLONAZEPAM (CLONEX) ומעוניינת להתייעץ לגבי הנזק בטיפול והחלופות אליו.

מה השפעת הפרמקולוגיה של CLONAZEPAM לתופעות הלוואי שלה בקשישים?

א. עקב עליה בספיגה התחלת הפעילות מהירה יותר בקשישים

ב. עקב עליה באחוז השומן בגוף זמן הפינוי של התרופה מהגוף ארוך יותר

ג. עקב ירידה בפינוי הכלייתי יש צורך להפחית מינון בקשישים

ד. בקשישים יש סיכון מוגבר להיווצרות מטבוליטים פעילים עם פינוי איטי

51. בן 84, ברקע ידוע על מחלת לב ראומטית, היצרות קשה של מסתם מיטראלי, מאושפז במחלקה גריאטרית לברור ממצא בצילום חזה.

בהתייעצות עם רופא ריאות הומלץ על ביצוע ברונכוסקופיה.

מה הטיפול המניעתי לאנדוקרדיטיס בחולה זה ?

א. בחולה זה אין צורך בטיפול מניעתי לאנדוקרדיטיס

ב. יש צורך במתן AMOXICILLIN 1000 מ"ג

ג. אם הוא רגיש לפניצילין יש צורך במתן VANCOMYCIN 1 גרם

ד. אם הוא לא מסוגל לבלוע יש צורך במתן AMPICILLIN 2 גרם

52. בת 87 מתלוננת שסובלת בשנה האחרונה מחולשה ותשישות כללית. היא ירדה במשקל מירידה במשקל (מ-65 ק"ג ל- 59 ק"ג). מדווחת שירדה בפעילות (מסתגרת בבית, הפסיקה לצאת לקניות, הפסיקה לנהוג ברכב). היא החלה ללכת עם מקל משום שהליכתה לא יציבה, ואף מעדה ונפלה פעם אחת ברחוב ומאז חוששת לצאת מהבית. מדווחת גם על ירידה בזיכרון לטווח הקצר בחודשים האחרונים.

מה מהממצאים של החולה מתאימים למאפיינים של FRAILTY לפי FRIED?

א. ירידה במשקל

ב. ירידה בזיכרון לטווח קצר

ג. פחד מנפילות

ד. הליכה לא יציבה

53. מה מאפיין את הזדקנות העור בנשים קשישות ?

א. בנשים עם עור כהה יש סיכון מוגבר ליובש וירידה בקולגן

ב. איבוד הקולגן הוא משמעותי ב- 5 השנים לאחר המנופאוזה

ג. hypoandrogenism

ד. עליה ברמות אלסטין ובפעילות בלוטות הזיעה

54. בן 79, ברקע יתר לחץ דם קשה לאיזון, טרום סוכרת ועודף משקל (BMI -30). מטופל קבוע ב- RAMIPRIL (TRITACE) ו- LERCANDIPINE (VASODIP).

פנה לבירור בתלונה שבשלוש השנים האחרונות הוא מתעורר בלילה כל שעתיים לערך, נותן שתן וחוזר לישון. בבוקר הוא מתעורר לרוב עם כאב ראש ומרגיש עייף. מדווח שאינו נוחר.

במשך היום נותן שתן כרגיל, ללא תכיפות או דחיפות.

פנה להערכה אורולוגית - אולטרסאונד הדגים ערמונית מעט מוגדלת, ללא שארית שתן.

אורולוג המליץ לנסות טיפול ב- TOLTERODINE (DETRUSITOL) באבחנה של שלפוחית רגיזה. תחת הטיפול לא נצפה שיפור.

מהו הצעד הסביר הבא?

א. התחלת בנזודיאזפין לשינה

ב. החלפת TOLTERODINE (DETRUSITOL) בחסם מוסקריני אחר כגון SOLIFENACIN (VESICARE)

ג. הפנייה לבדיקת שינה

ד. להמליץ על שימוש בבקבוק לשתן על יד המיטה, כך לא יצטרך לקום לשירותים.

55. מה מתאר מנגנון לעליה בסיכון למחלות זיהומיות בגיל המבוגר?

א. חסר ויטמין B12 גורם לירידה בתגובה לחיסון ל- pneumococcus

ב. עליה ביצור IL2 מתאי T גורמת לירידה בתגובה שלהם

ג. בירידה ברמת אלבומין מתחת ל-3 גרם/ד"ל מתחילים לראות ירידה בתגובה לחיסונים

ד. עודף ויטמין D מעלה סיכון לזיהומים בדרכי הנשימה

בחינת שלב א'- התמחות על גריאטריה 21.12.21

56. בן 84, סובל מדמנציה, אושפז במחלקת שיקום לאחר נפילה ושבר בצוואר הירך עם תיקון ניתוחי.

מצורפת טבלה עם ערכי FIM בקבלה לשיקום ולאחר חודש.

תחום	מדד	בקבלה	לאחר חודש בשיקום
ADL	אכילה	2	4
	טיפוח אישי והיגיינה	2	4
	רחצה	1	3
	לבוש פלג גוף עליון	2	4
	לבוש פלג גוף תחתון	1	1
	התארגנות בשירותים	1	3
	שליטה על סוגרים- שתן	1	4
	שליטה על סוגרים- יציאות	1	5
	סה"כ FIM ADL	**11**	**28**
מוטורי	מעברים ממיטה לכיסא	3	6
	מעברים לשירותים	3	6
	מעברים למקלחת	3	6
	ניידות הליכה	3	6
	ניידות מדרגות	3	6
	סה"כ FIM מוטורי	**15**	**30**
קוגניטיבי	הבנה שמיעתית	2	2
	יכולת ביטוי	2	3
	התנהגות חברתית	2	2
	פיתרון בעיות	2	2
	זיכרון	2	3
	סה"כ קוגניטיבי	**10**	**12**
כללי	**סה"כ**	**36**	**70**

מה המשקף את מצבו של המטופל לפי ערכי ה- FIM?

א. FIM קוגניטיבי עדיין לא השתפר ולכן יש מקום להמשך שיקום

ב. המטופל נזקק להשגחה עקב פער בין יכולתו המוטורית ליכולתו הקוגניטיבית

ג. לפי הערך הסופי מדובר בחולה סיעודי

ד. היות ו- FIM מוטורי השתפר משמעותית החולה יכול לתפקד באופן עצמאי

57. בן 83, נשוי ואב לשניים. ברקע: ידוע על ירידה קוגניטיבית קלה, עד לאשפוזו עצמאי בתפקודי BADL, לא מקבל עזרה מחוק סיעוד. מאושפז כעת במחלקה הקרדיולוגית באבחנה של אנדוקרדיטיס זיהומית, מקבל טיפול באנטיביוטיקה תוך ורידית ומתוכנן להמשך טיפול לשלושה שבועות נוספים. בימים האחרונים הופעת תמונה של אי ספיקת לב ומטופל במשתנים במינונים גבוהים בשיפור.

בהערכה לקראת שיקום – המטופל מדבר לעניין ומשתף פעולה. שוכב במיטה עם ראש מורם, מתנשם ומתקשה להשלים משפט. בבדיקה גופנית- בצקת גומתית ניכרת ברגליים. פצע לחץ דרגה 3 בעקב השמאלי. ביעוץ אורתופד המליץ להימנע מדריכה על הרגל.

מה מהבאים <u>ימנע</u> את מתן האישור להעברתו למחלקת שיקום?

א. קוצר נשימה עם חוסר יכולת להשלים משפט

ב. פצע לחץ דרגה 3

ג. רקע של ירידה קוגניטיבית

ד. איסור דריכה על רגל שמאל

58. בהתאם למאמר Management of Acute Hip Fracture - מה היתרון בהחלפת מפרק ירך מלא TOTAL HIP REPLACEMENT לעומת החלפת מפרק חלקי HEMIARTHROPLASTY ?

א. לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך מלא יש סיכון מוגבר לניתוח חוזר לעומת החלפה חלקית

ב. תפקוד המפרק אחרי החלפת מפרק מלא יותר טוב לעומת התפקוד לאחר החלפת מפרק חלקי

ג. פריקה או תת פריקה של תותב מתרחשת בשכיחות גבוה יותר לאחר ניתוח החלפת מפרק חלקי לעומת החלפת מפרק מלא

ד. זיהומים של המפרק מתרחשים בשכיחות גבוהה יותר לאחר החלפת מפרק מלא לעומת החלפת מפרק חלקי

59. בת 76 ברקע יתר לחץ דם, סוכרת, מחלת לב איסכמית מצב לאחר צנתור. באקו לב תפקוד לב 30%. אושפזה בעקבות החמרה באי ספיקת לב. בבדיקות המעבדה רמת Brain natriuretic peptide היתה 400 pg/mL (תקין <100). טופלה במשתנים עם שיפור.

מה גורם פרוגנוסטי טוב אצל המטופלת?

א. העובדה שמדובר ב HFREF (Heart failure reduced ejection fraction)

ב. מין נקבה

ג. מחלת לב איסכמית ברקע

ד. BNP גבוה

60. בן 87 , שמור קוגניטיבית, התקבל למחלקה אורתופדית לאחר נפילה. אובחן כסובל משבר בירך. ברקע סובל ממחלת לב כלילית, סוכרת, יתר לחץ דם. החולה מתוכנן לניתוח.

איזה ניתוח מתאים לפי סוג השבר ממנו סובל?

א. בשבר nondisplaced fracture Garden type I הניתוח המתאים הוא internal fixation

ב. בשבר displaced femoral-neck fracture הניתוח המתאים הוא internal fixation

ג. בשבר Intertrochanteric hip fractures הניתוח המתאים הוא arthroplasty

ד. בשבר displaced femoral-neck fracture בחולה זה עדיף טיפול שמרני ללא ניתוח

61. מטופלת בת 73, עם רקע של נפילות חוזרות. בבדיקה מתהלכת על בסיס רחב, מסתכלת למטה לכיוון כפות הרגליים בזמן הליכה, וכשצריכה להסתכל לכיוון אחר, נוטה לאבד שווי משקל.

מה מהבאים הוא ההסבר הכי סביר להפרעת ההליכה שלה?

א. מחלת פרקינסון מתקדמת

ב. שבץ מוחי עם פגיעה בקורטקס המוטורי

ג. בלט דיסק צווארי עם לחץ שורשי

ד. נוירופתיה סוכרתית מתקדמת

62. מי מהמטופלים הבאים שפנו למחלקה לרפואה דחופה עקב קוצר נשימה נמצא בחשד הגבוה ביותר לתסחיף ריאתי?

א. בן 85, ברקע קרצינומה של המעי הגס ברמיסיה. סימנים חיוניים- חום 38, דופק 95, לחץ דם 145/85, סטורציה 88%

ב. בת 78, שבועיים לאחר ניתוח עקב שבר בצואר הירך, מדווחת על שיעול דמי. סימנים חיוניים- דופק 120, לחץ דם 130/78, סטורציה 94%, ללא חום

ג. בת 68, ברקע סכרת ויתר לחץ דם, מתלוננת על כאבים בחזה וקוצר נשימה. סימנים חיוניים - דופק 92 לחץ דם 170/95 סטורציה 86% ללא חום

ד. בן 82, מעשן כבד. מתלונן על המופטיזיס. סימנים חיוניים - דופק 92 לחץ דם 150/75 סטורציה 89% ללא חום

63. בת 83 עצמאית בתפקודה ושמורה קוגניטיבית. ברקע סכרת מטופלת ב- METFORMIN עם המוגלובין A1C - 7.5% . מדווחת על בעיות ראיה.

פנתה למרפאה עקב הרגשה של הליכה לא יציבה. מספר פעמים מעדה במדרגות, ללא חבלות שהצריכו טיפול רפואי.

בבדיקה- ההליכה יציבה על בסיס צר. החולה השלימה מבחן TIMED UP AND GO במשך 16 שניות.

בבדיקת רופא עיניים נמצא קטרקט בעין ימין ומיופיה.

איזו התערבות למניעת נפילות יכולה להתאים למטופלת?

א. התאמת משקפיים מולטיפוקליות

ב. הליכה עם מקל או עם הליכון מחוץ לבית

ג. איזון סוכר הדוק יותר לפי הנחיות AGS

ד. ניתוח קטרקט

64. מה מאפיין דלקת פרקים מסוג RHEUMATOID ARTHRITIS במבוגרים?

א. יש מעורבות של גלילים דיסטליים לעומת פרוקסימליים

ב. יותר שכיח בנשים מאשר בגברים

ג. שכיח תסמיני SICCA

ד. אופיינית מעורבות של פרקים קטנים

65. בת 75, סובלת בחודשיים האחרונים מכאבי גב תחתון. ללא היסטוריה של חבלה או נפילה.
ללא היסטוריה של כאבי גב קודם לכן. יש לציין כי לפני חודשיים החלה ללכת עם נעליים חדשות.
בברור:
מיפוי עצמות לא הדגים קליטה פתולוגית
MRI עמוד שדרה הדגים ניוון של הדיסקים בין החוליות הלומבריות, בלט דיסק קל בין חוליה L3 לבין חוליה L4, אוסטאופיט בגוף חוליה L4.
יתכנו מספר גורמים לכאבי הגב . איזה מהגורמים הבאים **לא סביר**?

א. שרירים תפוסים בגב בשל שימוש בנעליים חדשות

ב. ניוון של הדיסקים בין החוליות הלומבריות

ג. בלט דיסק קל לימין בין חוליה L3 לבין חוליה L4

ד. שבר אוסטאופורוטי זעיר שלא נראה בהדמיה

66. ישנן הגדרות שונות לסרקופניה הכוללות שילוב של מדדים שונים.
מהו שילוב הממצאים שמגדירים סרקופניה?

א. מבחן SIX MINUTE WALK פחות מ- 400 מ' + ירידה ב- HAND GRIP

ב. מבחן St. Thomas risk assessment tool חיובי

ג. ירידה ב- HAND GRIP + ירידה ב- LEAN BODY MASS

ד. מבחן TIMED UP AND GO מעל 30 שניות + ירידה ב- LEAN BODY MASS

67. בן 78, אושפז לברור עקב קושי בבליעת מוצקים וירידה במשקל. הועלה חשד לקרצינומה של הושט.

מהם גורמי הסיכון לאדנוקרצינומה של הוושט בגיל המבוגר?

א. טיפול ממושך ב- PPI's

ב. שתיית אלכוהול

ג. רקע של Barrett esophagus

ד. אכלזיה

68. מטופל עם דמנציה מתקדמת מאושפז במחלקה הפנימית עם אבחנה של דלקת ראות.

נקראת לתת ייעוץ לקביעת מטרות טיפוליות.

לפי המאמר Advanced dementia של Mitchell מה משמעות הטיפול האנטיביוטי בחולה במצב זה?

א. על פי מחקרים אקראיים כפולי סמיות, טיפול אנטיביוטי הוא בעל ערך בהורדת נטל סימפטומים בחולים אלו

ב. טיפול אנטיביוטי בדלקת ריאות יעיל בהארכת חיים במטופלים אלו, אולם גם הגביר את הסבל מסימפטומים גופניים

ג. טיפול אנטיביוטי הוכח כמקל על סימפטומים רק בזיהומים בדרכי השתן

ד. מחלה זיהומית היא הסיבה השכיחה ביותר לסימפטומים גופניים בחולי דמנציה סופנית ולכן יש לתת טיפול אנטיביוטי אצלם מוקדם ככל האפשר

69. בת 67 התקבלה למחלקה עם תמונה של HERPES ZOSTER (שלבקת חוגרת). היא מתלוננת על כאבים עזים בבית חזה .לדבריה הכאבים התחילו 5 ימים לפני הופעת הפריחה. במחלקה הוחל טיפול אנטיוירלי ב- ZOVIRAX .

כל הגורמים הבאים מגבירים סיכון ל- POST HERPETIC NEURALGIA **פרט ל:**

א. הופעת כאב לפני פריחה

ב. כאב חזק בזמן הפריחה

ג. גיל מעל 70

ד. מעורבות של INTERCOSTAL NERVE

70. בבדיקה גופנית של חולה עם severe aortic regurgitation סביר שנמצא:

א. pulsus parvus et tardus

ב. pulsus paradoxus

ג. corrigan pulse

ד. pericardial knock

71. בת 88, דיירת מחלקה סיעודית, ברקע סכרת ויתר לחץ דם, התאשפזה עקב דלקת ריאות. מה מגורמי הרקע שלה מהווה גורם סיכון לדלקת ריאות?

א. סכרת

ב. מין נקבה

ג. טיפול ב- ENALADEX ליתר לחץ דם

ד. קבלת חיסון נגד שפעת 10 ימים לפני האשפוז

72. למי מהחולים הבאים כדאי להמליץ על טיפול במעכבי אצטיל כולין אסטרז?

א. בן 72, מתלונן על ירידה בזיכרון ומצב רוח ירוד. ללא הפרעה תפקודית. MOCA 27/30.

ב. בן 85 , סיעודי בתפקודו, מתגורר במחלקה סיעודית, אינו מזהה את בני המשפחה, לא ניתן לבצע אבחון קוגניטיבי פורמלי.

ג. בת 78, המשפחה מדווחת על ירידה בזיכרון, מאבדת חפצים, שוטטות. MMSE-23/30.

ד. בת 84, ברקע אפילפסיה עם פרכוס לאחרונה, זקוקה לעזרה בלבוש ורחצה. MMSE 12/30.

בחינת שלב א'- התמחות על גריאטריה 21.12.21

73. בן 75, סיעודי וסובל מדמנציה אושפז עקב התדרדרות במצב הכללי, ירידה במצב ההכרה וחום. סימנים חיוניים- דופק 115 , לחץ דם 90/40, סטורציה 75% באוויר חדר. בצילום חזה – הצללה בריאה ימנית.

במעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	156	135-146
K mmol/L	4.8	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	2.1	0.7-1.3
BUN mg/dL	70	5-25
WBC 10e3/µL	21,000	4.0-11.0
HgB g/dL	14.2	13.2-17 גבר
Plt 10e3/µL	354	150-450
CRP mg/L	200	<0.03-5
Ph	7.22	7.34-7.45
PO2 mmHg	50	70-100
PCO2 mmHg	58	35-46
HCO3 mmol/L	22	21-26

סוכם שמדובר בדלקת ריאות - הוחל טיפול אנטיביוטי רחב טווח, נוזלים, חובר למסכת חמצן.

מה מבין הנתונים מהווה את המרכיב המשמעותי ביותר בהערכת הפרוגנוזה לפי SCAP?

א. בלבול

ב. גיל מעל 70

ג. PH<7.3

ד. מדדי דלקת מוגברים

74. בת 86, מאושפזת במחלקה האורתופדית לאחר שבר צוואר ירך. עקב בלבול וחוסר התמצאות הוזמן יעוץ גריאטרי ואובחנה כסובלת מדליריום.

המשפחה מוטרדת מאוד מאפשרות שהמטופלת סובלת מדמנציה.

מה השלב הבא בהתנהלות?

א. יש לקחת אנמנזה קולטרלית הקשורה לדמנציה, ובמידה ועונה לקריטריונים ניתן לאבחן דמנציה במעמד היעוץ

ב. יש לבצע בדיקת MMSE ובמידה והיא לא תקינה ניתן לאבחן דמנציה

ג. במידה ואין אנמנזה מהמשפחה של ירידה קוגניטיבית מדובר בדליריום בלבד ואין צורך בברור נוסף

ד. דמנציה היא גורם סיכון לדליריום. מומלץ להפנותה למרפאה ייעודית להשלמת ברור לאחר יציאתה מהדליריום

75. מה מאפיין MCI?

א. כ- 15% מהחולים בכל שנה יתקדמו לאבחנה של דמנציה

ב. אין קשר בין סוג הפגיעה הקוגניטיבית לסיכוי להתקדם למחלת אלצהיימר

ג. כ- 50% מהאנשים מעל גיל 65 סובלים מ MCI

ד. MCI נבדל מ Subjective cognitive decline (SCD) בכך שב- MCI יש פגיעה בתפקוד היומיומי

76. תופעות בשימוש ארוך טווח ב- PPI's כוללות:

א. עליה בסיכון לטרנספורמציה נאופלסטית של Barrett esophagus

ב. עליה בספיגה של מגנזיום

ג. עליה בשכיחות שברי צוואר ירך

ד. עליה בתחלואה בשפעת

77. בת 85, ברקע דיכאון, פרפור עליות התקפי, היפרליפידמיה. אושפזה במחלקת פנימית גריאטרית בתמונה קלינית של דלקת ריאות.

תרופות:

ECITRALOPAM 30 mg X1

AMIODARONE 200 mg X1

RIVAROXABAN 15 mg X1

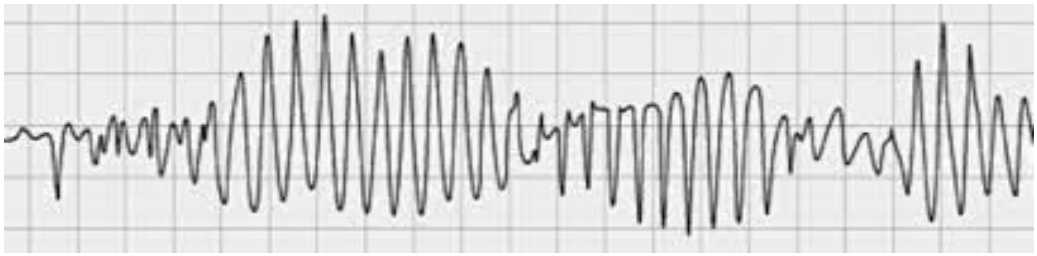
הותחל טיפול ב- LEVOFLOXACIN (TAVANIC)

יומיים לאחר האשפוז היא נמצאת מחוסרת הכרה במיטתה.

הממצא במוניטור מופיע בתמונה 3.

מספר תרופות אותן החולה מקבלת יכולות לגרום לתופעה זו.

איזו תרופה **לא** גורמת לתופעה?



א. AMIODARONE

ב. ECITRALOPAM

ג. LEVOFLOXACIN

ד. RIVAROXABAN

78. מה מתאר את הטיפול במחלת אלצהיימר עם מעכבי כולין אסטרז?

א. מרבית החולים חווים עצירה או האטה של הירידה הקוגניטיבית

ב. מחקרים חדשים מראים שסוג זה של תרופות אינו Cost-Effective

ג. מעכבים מעבר מ- MCI למחלת אלצהיימר

ד. קיימים במתן פומי בלבד

79. מה הקשר בין דיכאון לבין מחלות "גופניות"?

א. דיכאון בחולי סרטן שכיח יותר בגברים

ב. דיכאון יכול להיות תופעת לוואי שכיחה של טיפול ב- ACE INHIBITORS

ג. דיכאון משני לשבר בצוואר הירך נוטה להמשיך לטווח ארוך

ד. דיכאון בחולי סרטן נמצא בקורלציה עם חומרת הכאב

80. בת 92 מאושפזת במחלקה אורתופדית יומיים לאחר ניתוח קיבוע שבר ירך בעקבות נפילה. עד הנפילה הייתה ללא ירידה קוגניטיבית ידועה, גרה בבית לבד עם עזרה של מטפלת 15 שעות בשבוע. בנה שהגיע לבקר מצא אותה מדברת עם דמויות אשר לא קיימות בחדר, קוראת לו בשם של אביו אשר נפטר לפני 10 שנים ומנסה לקום מהמיטה.

רופא במחלקה מספר שעקב בלבול ואי שקט החולה קיבלה PHENERGAN, HALIDOL ו- VABEN.

מה המשך הטיפול במצב זה?

א. החולה כרגע בדליריום לכן צריך כמה שיותר מהר להחזיר אותה לסביבה הטבעית שלה שזה ביתה

ב. לנסות להפסיק טיפול בבנזודיאזפינים, תרופות אנטיכולינרגיות ואנטיהסטמינים

ג. חובה להכניס קתטר כדי לקחת תרבית שתן מכוון שזיהום בדרכי השתן הוא סיבה שכיחה לדליריום

ד. מומלץ להימנע מתרופות אנלגטיות

81. איזה גורם פיזיולוגי מעלה סיכון להיפוגליקמיה בגיל המבוגר?

א. ספיגה מואצת של פחמימות במעי

ב. תפקוד beta adrenergic receptor מוגבר

ג. ירידה בפינוי אינסולין בכליה

ד. עליה בהפרשת גלוקגון

82. בת 86, התקבלה למחלקת סיעוד מורכב עקב פצע לחץ דרגה 4 עמוק ומזוהם באזור הסאקרום. קיבלה טיפול מקומי בפצע באמצעות ניקוי והסרת הרקמות הנימקיות. כעבור שבועיים עדיין הפרשה מרובה עם ריח אופנסיבי, סימני צלוליטיס מסביב, ללא חום סיסטמי. בספירת דם 13,000 לויקוציטים , CRP = 24.5 (תקין עד 0.5).

נלקח מטוש לתרבית עם צמיחה של Pseudomonas aeruginosa ו- Providencia.

מה הטיפול המתאים במצב זה?

א. טיפול מקומי בפצע בלבד. אין צורך בטיפול אנטיביוטי

ב. אנטיביוטיקה רחבת טווח

ג. טיפול אנטיביוטי סיסטמי מותאם לרגישות החיידקים שצמחו

ד. הטיפול ב VAC (לחץ שלילי) הוא טיפול הבחירה בפצע מזוהם

83. בת 82 ברקע דמנציה עם הפרעות התנהגות קשות. דיירת מחלקה לתשושי נפש. מטופלת בין השאר ב- VENLAFAXINE (EFFEXOR), CLOZAPINE (LEPONEX), ALPRAZPLAM (XANAX) ו- ZOLPIDEM (ZODORM) . הגיעה לחדר מיון עקב חום. בבדיקות מעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
WBC 10e3/µL	2600	4.0-11.0
NEU %	29.5	40.0-75.0
NEU No. 10e3/µL	0.8	1.4-6.0
HgB g/dL	13.3	אשה 11.7-15.5
Plt 10e3/µL	235	150-450

איזה מבין התרופות הבאות הינו הגורם להפרעה בספירת הדם בסבירות הגבוהה ביותר?

א. VENLAFAXINE (EFFEXOR)

ב. CLOZAPINE (LEPONEX)

ג. ALPRAZPLAM (XANAX)

ד. ZOLPIDEM (ZODORM)

84. בת 75 , עצמאית בתפקודה, מעשנת כבדה. אובחנה כסובלת מ- CAROTID ARTERY STENOSIS עקב ממצא מקרי של אוושה בצוואר בבדיקה גופנית. בדופלקס נמצא חסימה של 80%.

מה הטיפול במצבה?

א. התחלת טיפול בסטטינים רק במידה ויש לה היפרליפידמיה

ב. ניתוח carotid endarterectomy

ג. שינוי אורחות חיים כולל הפסקת עישון ומעקב לחצי שנה

ד. צנתור וסטנט לעורק הקרוטידי

85. בת 92, מאושפזת במחלקת אורתופדיה לאחר ניתוח תיקון שבר צוואר ירך. ברקע: דמנציה, מטופלת ב- DONEPEZIL. במהלך הבתר ניתוחי הצוות שמו לב שהיא ישנונית, אינה מתמצאת בזמן או במקום, מתקשה לבצע הוראות של צוות פיזיותרפיה. יש תנודות במצב ההכרה ובמצב הקוגניטיבי במהלך היום. ביום השני לאחר הניתוח – הוצא צנתר משלפוחית השתן. מעקב שארית שתן- ללא שארית.

עקב ניסיון לתלוש את העירוי, ידיה של המטופלת נקשרו.

אילו מבין הגורמים הבאים תורם לתסמונת ממנה היא סובלת כעת?

א. פיזיותרפיה בעיתוי מוקדם מדי לאחר הניתוח

ב. הוצאת הצנתר מכיס השתן

ג. קשירה של הידיים

ד. תגובה ממושכת לתרופות אינדוקציה סביב הניתוח

86. בן 78 , ימני, התקבל למחלקת שיקום גריאטרי לאחר שבץ בטריטוריה של Rt. Middle cerebral artery.

מה הממצאים הצפויים פרט לפלגיה משמאל?

א. aphasia

ב. סטיית מבט לשמאל

ג. neglect

ד. חרשות באוזן ימין

87. בת 86, תשושה בתפקודה וסובלת מדמנציה עם הפרעות התנהגות. מתגוררת לבדה ונעזרת במטפלת שעתיים ליום. ברקע אי ספיקת לב, יתר לחץ דם ודיכאון. מטופלת תרופתית ב- ECITRALOPAM (CIPRALEX), ASPIRIN, RAMIPRIL (TRITACE) ו- BISOPROLOL (CARDILOC).

הובאה למלר"ד עקב בלבול חריף. בבדיקה גופנית- ללא סימני אגירת נוזלים.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות	החולה	ערכים תקינים
Na mmol/L	126	135-146
K mmol/L	3.7	3.5-5.3
CREATININE mg/dL	0.6	0.7-1.3
BUN mg/dL	11	5-25
בשתן Osmolality mosmol/Kg	95	300-1300
בשתן Na mmol/L	13	29-145

מה הסיבה האפשרית ביותר לממצא המעבדתי?

א. SIADH משני לטיפול תרופתי ב- ECITRALOPAM (CIPRALEX)

ב. החמרה של אי ספיקת לב

ג. דהידרציה משנית לשלשול והקאה

ד. שתיה מרובה

88. בת 75, ברקע אי ספיקת לב, סוכרת, יתר לחץ דם, וזיהומים חוזרים בדרכי השתן עם טיפול אנטיביוטי מניעתי. פונה למרפאה בגין קשיי נשימה שהתחילו בצורה הדרגתית. בבדיקתה – סטורציה נמוכה, בהאזנה לריאות – קרפיטציות עדינות דו צדדיות בסוף אינספיריום.

לאיזה מהתרופות שמקבלת יכול להיות קשר למחלתה?

א. AMLODIPINE

ב. METFORMIN

ג. SPIRONOLACTONE

ד. NITOFURANTOIN

89. בת 60, סובלת בחודשים האחרונים משינויים קוגניטיביים ושינויים התנהגותיים. מדברת באופן בוטה , לא מתעניינת בדברים שעינינו אותה בעבר , חוזרת פעמים רבות על אותם משפטים. בבדיקה הקוגניטיבית בולטת פגיעה בתפקודים הניהוליים (Executive functions) והזיכרון יחסית שמור.

מה הממצא ההדמייתי האופייני במצב זה?

א. MRI מוח יראה ירידה בנפח המוח

ב. CT אנגיוגרפיה יראה אוטמים מרובים ופגיעה ווסקולרית

ג. מיפוי PET FDG יראה ירידה במטבוליזם באונות הפרונטליות

ד. CT יראה נפח חדרים מוגבר עם השטחה של הסולקים

90. בת 78, פנתה להערכה במרפאה גריאטרית עקב סחרחורת שקיימת כשנה. בשנה האחרונה נפלה 3 פעמים, ללא חבלות משמעותיות.

מה המשפט המתאר נכון את הסיבות האפשריות לסחרחורת?

א. Benign Paroxysmal Positional Vertigo מופיע באופן פתאומי, לפעמים לאחר תנועה חדה עם הראש

ב. ב- Ménière Disease הסחרחורת היא ממושכת ויומיומית

ג. ב - Acoustic Neuroma החולה מתלונן בדרך כלל על TRUE VERTIGO

ד. ב- Recurrent Vestibulopathy ניתן למצוא ירידה ניכרת בשמיעה באוזן אחת

91. אילו מבין השינויים הבאים של ההזדקנות קשורים להתמודדות אדם זקן עם COPD ?

א. עליה ב- cardiac output

ב. ירידה ב- peripheral vascular resistance

ג. ירידה בלחץ בעורקי הריאה

ד. סיכון מוגבר לאוסטאופורוזיס

92. בת 70, מתלוננת כי מספר שנים סובלת מרעד בשתי הידיים ובראש אשר החמיר לאחרונה. אינה מסוגלת להשתמש בכף כדי לאכול מרק , כיוון הנוזל נשפך מהכף. שתיית אלכוהול מקלה על הרעד ואילו מתח נפשי מחמיר אותו. בבדיקה מדובר ברעד דו צדדי (יד ימין ויד שמאל) סימטרי בחומרתו, רעד בראש ושאר הבדיקה הנוירולוגית תקינה.

מה הטיפול המומלץ לרעד ?

א. LEVODOPA+CARBIDOPA (DOPICAR)

ב. Beta blockers

ג. Calcium channel blockers

ד. AMANTADINE

93. בת 84, עצמאית בתפקודה וללא ירידה קוגניטיבית ידועה. ברקע סוכרת ויתר לחץ דם. מה צריך לכלול הטיפול בסוכרת על פי המאמר

Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes 2020 ?

א. איזון סוכרת עם המוגלובין A1C מתחת ל- 7.5% והערכה קוגניטיבית אחת לשנה

ב. איזון סוכרת עם המוגלובין A1C מתחת ל-7% ואיזון לחץ דם מתחת ל- 130/80

ג. איזון סוכרת עם ערכי גלוקוז בצום 100-200 ומתן טיפול בסטטינים

ד. איזון סוכרת עם ערכי גלוקוז בצום 70-100 ובדיקת גילוי מוקדם לכף רגל סוכרתית

94. בת 96 , סובלת מדמנציה. גרה בבית עם מטפלת 24 שעות. החולה הולכת עם הליכון בהשגחה. לפני שנתיים חוותה שבץ מוחי ומאז סובלת מחולשת פלג גוף ימין קלה. החולה נפלה שלוש פעמים בשנה החולפת . בבדיקה גופנית לחץ הדם בשכיבה הוא 145/80 ממ"כ, ולאחר שלוש דקות עמידה הוא 110/65 ממ"כ.

לחולה מספר גורמי סיכון לנפילות.

לאיזה גורם סיכון **הקשר החלש** ביותר לנפילות?

א. גיל מבוגר

ב. אורתוסטטיזם

ג. שבץ בעבר

ד. ירידה קוגניטיבית

95. בת 85, הסובלת מסרטן גרורתי ודמנציה מתקדמת הוכרזה כחולה נוטה למות שאינה כשירה. בברור רצונה נמצא כי תוקף ייפוי הכוח עליו חתמה ובו מינתה את שכנתה, פג לפני שנתיים, אך לאחרונה מונה לה אפוטרופוס מטעם המדינה.

מי צריך להיות מקבל ההחלטה בעניין הטיפול בסוף החיים?

א. האפוטרופוס

ב. אחייניתה שהינה קרובת המשפחה היחידה שלה

ג. הרופא האחראי בהתייעצות עם השכנה

ד. הרופא האחראי בהתייעצות עם האפוטרופוס

96. מה הייחוד של טיפול פליאטיבי בחולי דמנציה מטיפול פליאטיבי בחולים אונקולוגים?

א. בחולי דמנציה אין צורך בטיפול בכאב היות והשכיחות של כאב היא נמוכה

ב. טיפול פליאטיבי בחולי דמנציה יכול התבצע בצורה טובה על ידי הצוות המטפל ואין חשיבות להכנסה של מומחים בטיפול פליאטיבי

ג. חולי דמנציה מתקדמת סובלים מנטל סימפטומים גופניים משמעותי ובזה אינם שונים מחולים אונקולוגים

ד. שילוב של טיפול פליאטיבי בחולי דמנציה חשוב רק בשלבים המתקדמים של המחלה

97. הוזמן ייעוץ שיקומי לבן 79 המאושפז במחלקה כירורגית לאחר כריתת כיס מרה דחופה. החולה מוזן כעת בזונדה, משתף פעולה חלקית בפיזיותרפיה ובבדיקה נמצא פצע לחץ דרגה 3 בעכוז. במעבדה- לויקוציטים 11,400, CRP-13.

מה ההמלצה להמשך שיקום לחולה זה?

א. בשל פצע לחץ דרגה 3 מתאים למחלקה לסיעוד מורכב בלבד

ב. לצורך קבלתו למחלקת שיקום יש לגמול אותו קודם מזונדה

ג. יש להמתין עד להתנרמלות מדדי דלקת ואז לקבלו לשיקום

ד. ניתן לקבלו למחלקה שיקומית בתנאי שמסכים ומשתף פעולה בטיפול

98. בת 88 פנתה למיון עקב שקיעה במצב ההכרה. לפני שבוע נפלה ונחבלה וסבלה מכאבים קשים. המשפחה יודעת שהחולה לקחה תכשירים שונים לשיכוך כאב, ולאחר מכן הפכה להיות שקועה. המשפחה מביאה שקית עם תרופות אנלגטיות שונות אותן החולה לקחה בבית בשבוע האחרון.

מי מבין התרופות האנלגטיות הבאות יכולה לגרום בסבירות גבוהה לשקיעה הכרתית?

א. ACAMOL FOCUS (PARACETAMOL, ASPIRIN, CAFFEINE)

ב. COMBODEX (PARACETAMOL, IBUPROFEN)

ג. MUSCOL (PARACETAMOL, ORPHENADRINE)

ד. DIPYRONE (OPTALGIN)

99. מה מאפיין את הזקנים בארץ מבחינה פסיכו-סוציאלית לפי לקט הנתונים האינפוגרפי של השנתון הסטטיסטי?

א. אחוז בני 65+ בקרב הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים גדול מחלקם באוכלוסייה

ב. קופת חולים מכבי היא בעלת אחוז הזקנים הגבוה ביותר

ג. כ- 8% מבני 75 ומעלה שוהים במוסד

ד. רוב הנשים בנות 70 ומעלה מקבלות "גמלת סיעוד"

100. בת 75, אושפזה בשל חשד לדלקת ריאות במחלקה הפנימית, בשל שיעול של כשבועיים. במהלך אשפוזה בוצע CT ריאות, ללא לתסנין, אולם הודגמו ממצאים בבלוטת התריס. תפקודי תריס נלקחו, אשר תקינים.

באיזה ממצא בתירואיד יש להמשיך בברור על ידי FNA ?

א. יש לדגום כל Multinodular Goiter (MNG) בשל סיכון לממאירות

ב. נודול סולידי (Solid) בגודל של 2 ס"מ, עם מיקרוקלציפיקציות

ג. יש לדגום כל נודול ציסטי (Purely cystic nodules), לשלילת Cystic Carcinoma

ד. גוש "חם" במיפוי תירואיד

בהצלחה